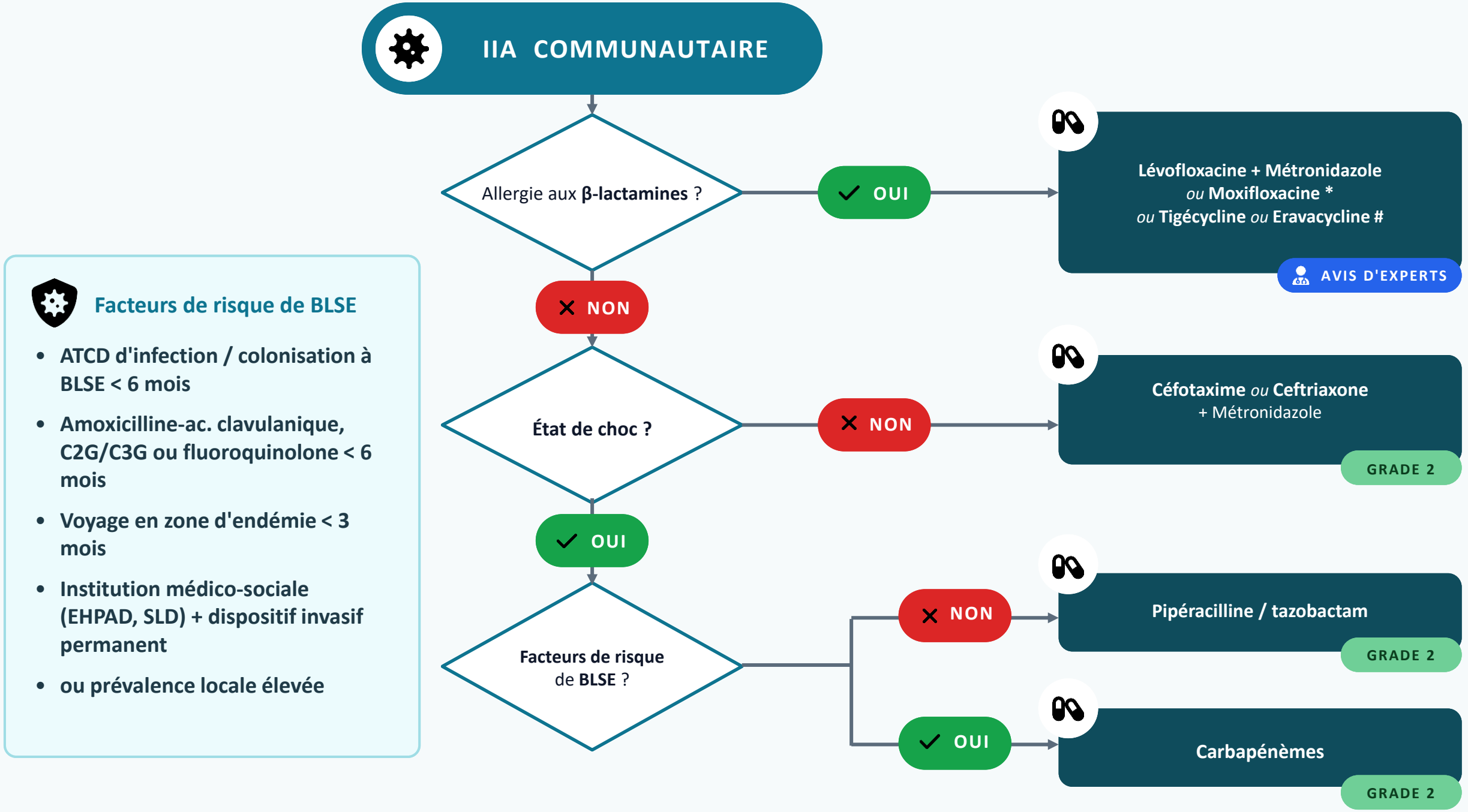

IIA COMMUNAUTAIRE
Allergie aux β-lactamines ?
OUI
Lévofloxacine + Métronidazole
ou Moxifloxacine *
ou Tigécycline ou Eravacycline #
AVIS D'EXPERTS
NON
État de choc ?
NON
Céfotaxime ou Ceftriaxone
+ Métronidazole
GRADE 2
OUI
Facteurs de risque
de BLSE ?
NON
Pipéracilline / tazobactam
GRADE 2
OUI
Carbapénèmes
GRADE 2
Facteurs de risque de BLSE
ATCD d'infection / colonisation à BLSE < 6 mois
Amoxicilline-ac. clavulanique, C2G/C3G ou fluoroquinolone < 6 mois
Voyage en zone d'endémie < 3 mois
Institution médico-sociale (EHPAD, SLD) + dispositif invasif permanent
ou prévalence locale élevée

IIA ASSOCIÉE AUX SOINS

Allergie aux **β-lactamines** ?

✓ OUI

Ciprofloxacine + métronidazole
ou **Aztréonam + métronidazole**
ou **Tigécycline / éravacycline**
+ ciprofloxacine *

AVIS D'EXPERTS

✕ NON

Facteurs de risque de **BMR** ?

✕ NON

Céfépime + métronidazole

GRADE 1

Pipéracilline-tazobactam

AVIS D'EXPERTS

✓ OUI

Imipénème *ou* **méropénème**

GRADE 2

+

Facteurs de risque d'entérocoque **AmpiR** ?

✓ OUI

+

Linézolide *ou* **Vancomycine** *ou* **Teicoplanine**
*à ajouter à tous les régimes précédents (sauf *)*

AVIS D'EXPERTS

Facteurs de risque de BMR

- **C3G ou fluoroquinolone < 3 mois ; portage < 3 mois de BLSE ou P. aeruginosa CAZ-R**
- **Hospitalisation à l'étranger < 12 mois ; institution médico-sociale + dispositif invasif**
- **Échec ou récidive < 15 j après C3G, fluoroquinolone ou pip-tazo (≥ 3 j)**

FdR d'entérocoque AmpiR

- **Point de départ hépato-biliaire ; transplantation hépatique ; immunodépression**
- **Patient déjà sous antibiothérapie ou C3G préalable**

INFECTION INTRA-ABDOMINALE

Examen direct positif à levure
ou **Peritonitis Score ≥ 3**

- ✓ OUI → **Défaillance hémodynamique** *ou* **IIA associée aux soins**
  - ✓ OUI → **Facteur de risque** de souche **résistante au fluconazole** *ou* **complication postopératoire** après IIA
    - ✓ OUI → **Échinocandine**
    - ✗ NON → **Fluconazole**
  - ✗ NON → **Pas de traitement antifongique**
- ✗ NON → **Pas de traitement antifongique**

Peritonitis Score (1 pt / critère)

- Défaillance hémodynamique
- Sexe féminin
- Chirurgie sus-mésocolique
- Antibiothérapie > 48 h

Endossement RFE SFAR 2015

R21 — patient grave (IIA communautaire ou associée aux soins) : si antifongique probabiliste décidé, utiliser une échinocandine.

R41 — IIA associée aux soins : antifongique probabiliste si levure à l'examen direct ou culture péritonéale positive (échinocandine si infection grave ou souche fluconazole-R).